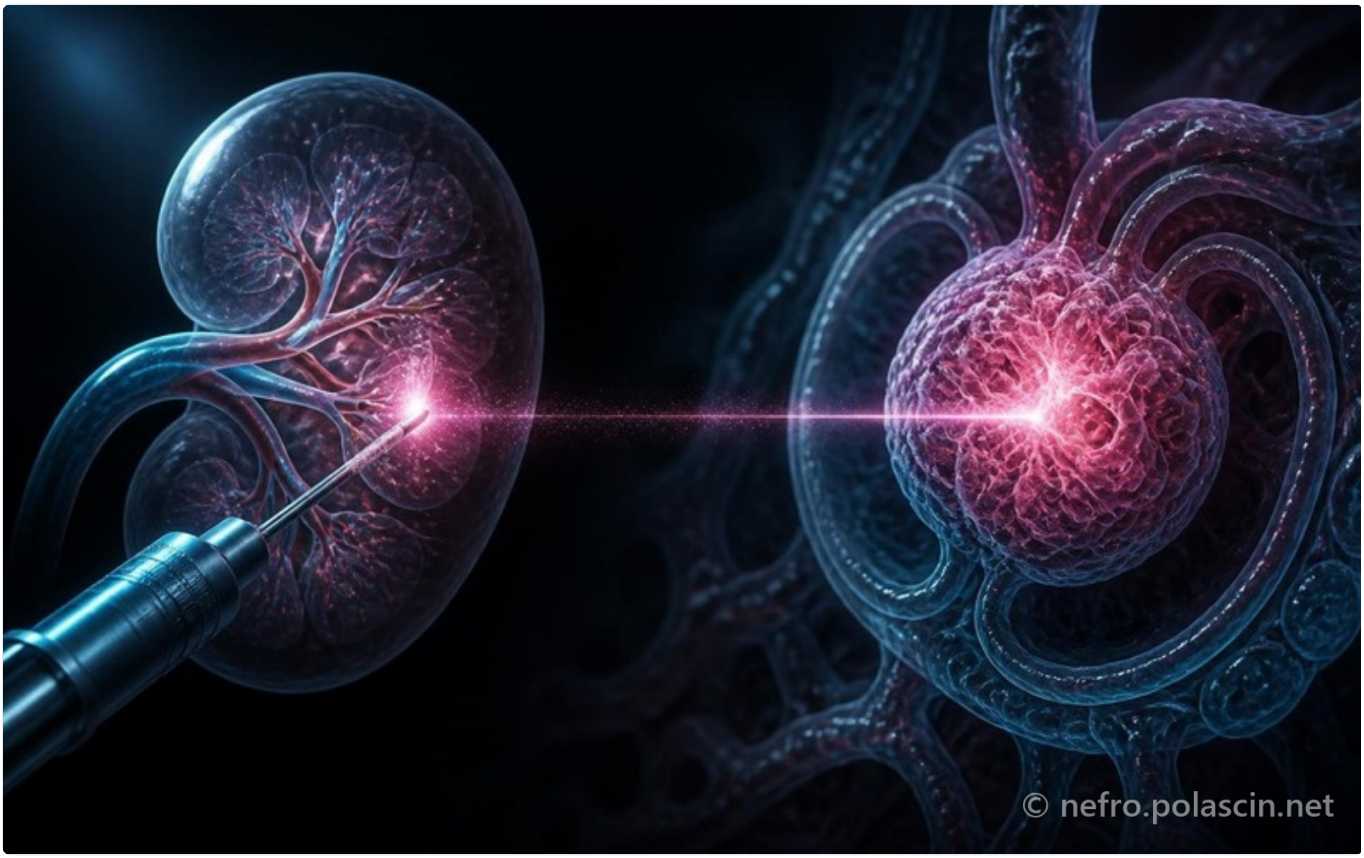
IgA nefropatia podľa KDIGO 2025 a KDOQI US Commentary: od biopsie po cielenejšiu liečbu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Biopsia nie je formalita – od nej sa odvíja, ktorá cielená liečba má pre pacienta zmysel.

IgA nefropatia (IgAN) je heterogénne imunitne podmienené ochorenie s variabilným klinickým priebehom. KDIGO 2025 posúva manažment k včasnému rozpoznaniu rizikových pacientov a k liečbe zameranej na hlavné mechanizmy ochorenia. KDOQI US Commentary spresňuje, ako tieto odporúčania uplatniť v každodennej klinickej praxi.

1) Diagnóza IgAN: kľúčová je biopsia

KDOQI commentary súhlasí s tým, že **IgAN možno potvrdiť iba obličkovou biopsiou**. Neexistujú validované sérové ani močové biomarkery, ktoré by diagnózu spoľahlivo nahradili.

Kedy uvažovať o biopsii

KDIGO odporúča biopsiu zvážiť u dospelých s **proteinúriou ≥ 0,5 g/deň** alebo ekvivalentom, ak IgAN prichádza do úvahy a biopsia nie je kontraindikovaná.

Po potvrdení diagnózy

Po potvrdení IgAN sa má zhodnotiť aj možné **sekundárne pozadie** a pri primárnej IgAN sa má určiť **MEST-C skóre** podľa revidovanej Oxford klasifikácie.

2) Prognóza: riziko sa dá kvantifikovať, odpoveď na liečbu nie

KDIGO aj KDOQI zdôrazňujú, že pri IgAN nie sú validované prognostické biomarkery v krvi ani v moči. Prognóza sa preto opiera najmä o:

- **eGFR**,

- **proteinúriu**.

IgAN prediction tools

Medzinárodné predikčné nástroje majú význam na **rizikovú stratifikáciu** a môžu podporiť zdieľané rozhodovanie s pacientom. KDOQI však upozorňuje, že tieto nástroje **nemajú slúžiť na výber konkrétneho lieku** ani na predikciu, kto na ktorú liečbu zareaguje. Neodporúčajú sa ani pre atypické fenotypy, ktoré neboli v pôvodných kohortách dostatočne zastúpené, napríklad pri akútnej nefritickej prezentácii, nefrotickom syndróme alebo rýchlo progredujúcej glomerulonefritíde.

3) Cieľ liečby: spomaliť pokles eGFR a znížiť proteinúriu

KDIGO nastavuje cieľ liečby tak, aby sa rýchlosť poklesu eGFR približovala fyziologickému tempu pre väčšinu dospelých, teda približne **< 1 ml/min/rok**. Najpraktickejším skorým markerom odpovede zostáva proteinúria, ktorá má byť minimálne **< 0,5 g/deň** a ideálne **< 0,3 g/deň**.

KDOQI zároveň pripomína, že u pacientov s pokročilým jazvením nemusí byť tento cieľ realisticky dosiahnuteľný a bude treba kombinovať farmakologické aj nefarmakologické postupy.

4) Základ liečby rizikových pacientov: zásah do viacerých mechanizmov naraz

KDOQI commentary podporuje mechanistický rámec KDIGO: u väčšiny rizikových pacientov má manažment súčasne:

1. obmedziť tvorbu IgA-obsahujúcich imunitných komplexov a glomerulárne poškodenie s nimi spojené,
2. manažovať dôsledky straty nefrónov, pravdepodobne celoživotne.

Praktický dôraz je na kombinácii liekov pôsobiacich na viacero článkov patofyziológie, nie iba na izolované znižovanie proteinúrie bez ovplyvnenia mechanizmov ochorenia.

5) Praktické nefarmakologické a podporné kroky

Praktické body KDIGO sú konkrétne a komentár zdôrazňuje, že nejde o „doplnky“, ale o skutočné terapeutické zásahy:

- **zníženie príjmu sodíka** pod 2 g/deň,
- **ukončenie fajčenia a vapingu**,
- **kontrola hmotnosti** a vhodná aeróbna aktivita,
- **cieľ tlaku krvi ≤ 120/70 mm Hg**,
- **blokáda RAS** (ACEi/ARB) a podľa situácie aj stratégia na zníženie hyperfiltrácie,
- zváženie **inhibítora SGLT2** ako súčasti nefroprotektívneho rámca,
- komplexná kardiovaskulárna prevencia podľa lokálnych odporúčaní,
- v ideálnom prípade zváženie **klinickej skúšky**, ak je dostupná.

6) IgAN špecifická terapia: Nefecon ako preferovaná možnosť, ak je dostupný

KDIGO odporúča **9-mesačnú kúru Nefeconu** u pacientov v riziku progresie, typicky v skupine 2B.

Čo treba vedieť pred začiatkom Nefeconu

KDOQI commentary podporuje princíp odporúčania, ale pripomína praktické limity:

- odpoveď nemusí byť dlhodobá po ukončení liečby,
- údaje o opakovaných cykloch sú stále obmedzené,
- dostupnosť a schválenie sa medzi krajinami líšia.

Bezpečnosť a systémový tieň lokálneho steroidu

Aj keď je Nefecon koncipovaný ako lokálny kortikosteroid s menšou systémovou expozíciou, KDOQI upozorňuje, že treba počítať s obmedzenou absorpciou a klinicky významnými nežiaducimi účinkami. V štúdii boli závažné nežiaduce udalosti počas 9-mesačnej liečby častejšie v aktívnej skupine a častejšie bolo aj ukončenie liečby pre

nežiaduce udalosti. V úvode liečby sa môže objaviť aj fenomén **reverse dip** na eGFR.

Pacientovi treba preto vysvetliť, že krátkodobé zmeny proteinúrie alebo eGFR ešte neznamenajú neúspech či úspech liečby.

7) Ak Nefecon nie je dostupný: znížená dávka systémových kortikoidov s profylaxiou

V prostredí bez Nefeconu KDOQI podporuje KDIGO odporúčanie použiť **6 až 9 mesiacov zníženej dávky systémového glukokortikoidu** s vhodnou profylaxiou.

Odporúčaný režim methylprednizolónu

- **0,4 mg/kg/deň**, maximálne **32 mg/deň**, počas **2 mesiacov**,
- potom postupné znižovanie o **4 mg/deň každý mesiac**,
- celková dĺžka liečby **6 až 9 mesiacov**.

Povinná bezpečnostná vrstva

Liečba má byť sprevádzaná:

- **antimykotickou profylaxiou** proti *Pneumocystis jirovecii*,
- **antivírusovou profylaxiou** u nosičov HBsAg,
- **gastroprotekciou** a **ochranou kostí** podľa lokálnych odporúčaní.

Pacienti s vyšším rizikom toxicity kortikoidov

KDOQI upozorňuje na zvýšenú obozretnosť najmä pri týchto faktoroch:

- eGFR < 30 ml/min/1,73 m²,
- diabetes alebo prediabetes,
- obezita,
- latentné infekcie, napríklad vírusové hepatitídy alebo tuberkulóza,
- aktívna peptická ulcerácia,
- nekontrolované psychiatrické ochorenie,
- osteoporóza,
- katarakta.

Záver pre prax

V manažmente IgAN sa ťažisko presúva na tri body: správnu diagnostiku, včasné rizikové zhodnotenie a liečbu zameranú na mechanizmy ochorenia. Bez biopsie sa diagnóza potvrdiť nedá, proteinúria ≥ 0,5 g/deň nie je banálna a cieľom je spomaliť pokles eGFR. Nefecon je preferovaným 9-mesačným zásahom, ak je dostupný; pri nedostupnosti sa zvažujú znížené dávky systémových kortikoidov s profylaxiou.

Zdroj: *KDOQI US Commentary on the KDIGO 2025 Clinical Practice Guideline for IgA Nephropathy and IgA Vasculitis (AJKD, full text). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=iga-nefropatia-kdigo-2025-kdoqi · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.